

Entendiendo al usuario (PCM)

Equipo 13

Cómo analizamos el caso

1 Primer informe clínico

Datos objetivos: diagnóstico, examen físico, rehabilitación y equipos usados.

2 Entrevista

Contexto personal: familia, vivienda, transporte, actividades y molestias actuales.

3 Criterio clínico

Diferenciamos datos confirmados, inferencias razonables e información pendiente.



Información personal y apoyo económico

Nombre: PCM (identificado por iniciales).

Edad: 49 años.

Procedencia: Junín.

Residencia: San Martín de Pangoa, Junín.

Vivienda: Primer piso en la vivienda (material noble) de una tía del paciente

Tratamiento actual:

El paciente permanece hospitalizado, dentro de un programa de rehabilitación multidisciplinario cuya duración habitual es de 3 a 4 meses



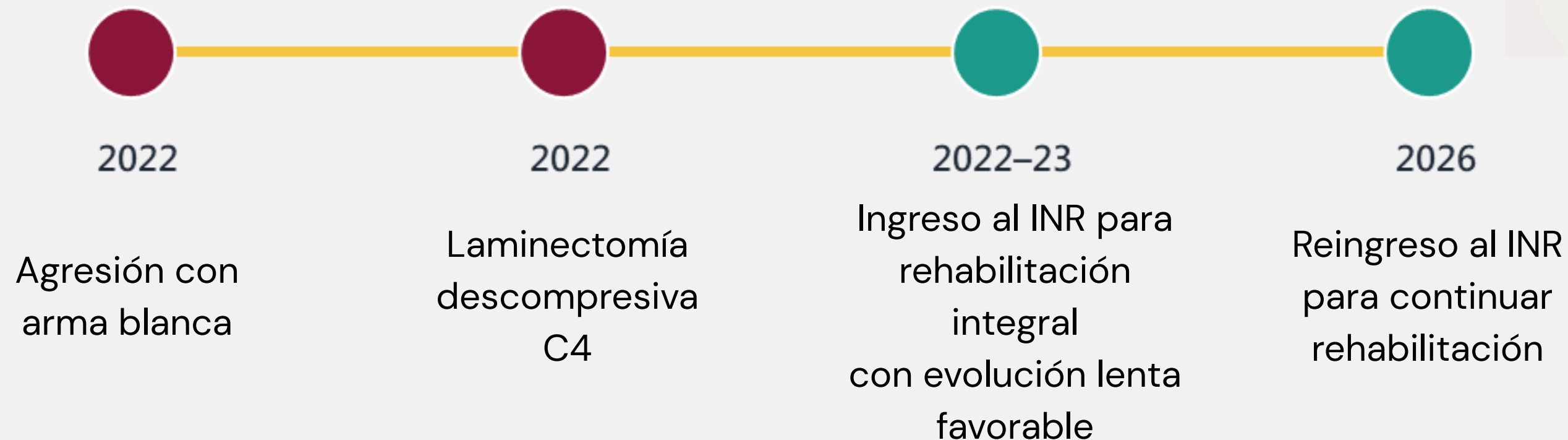
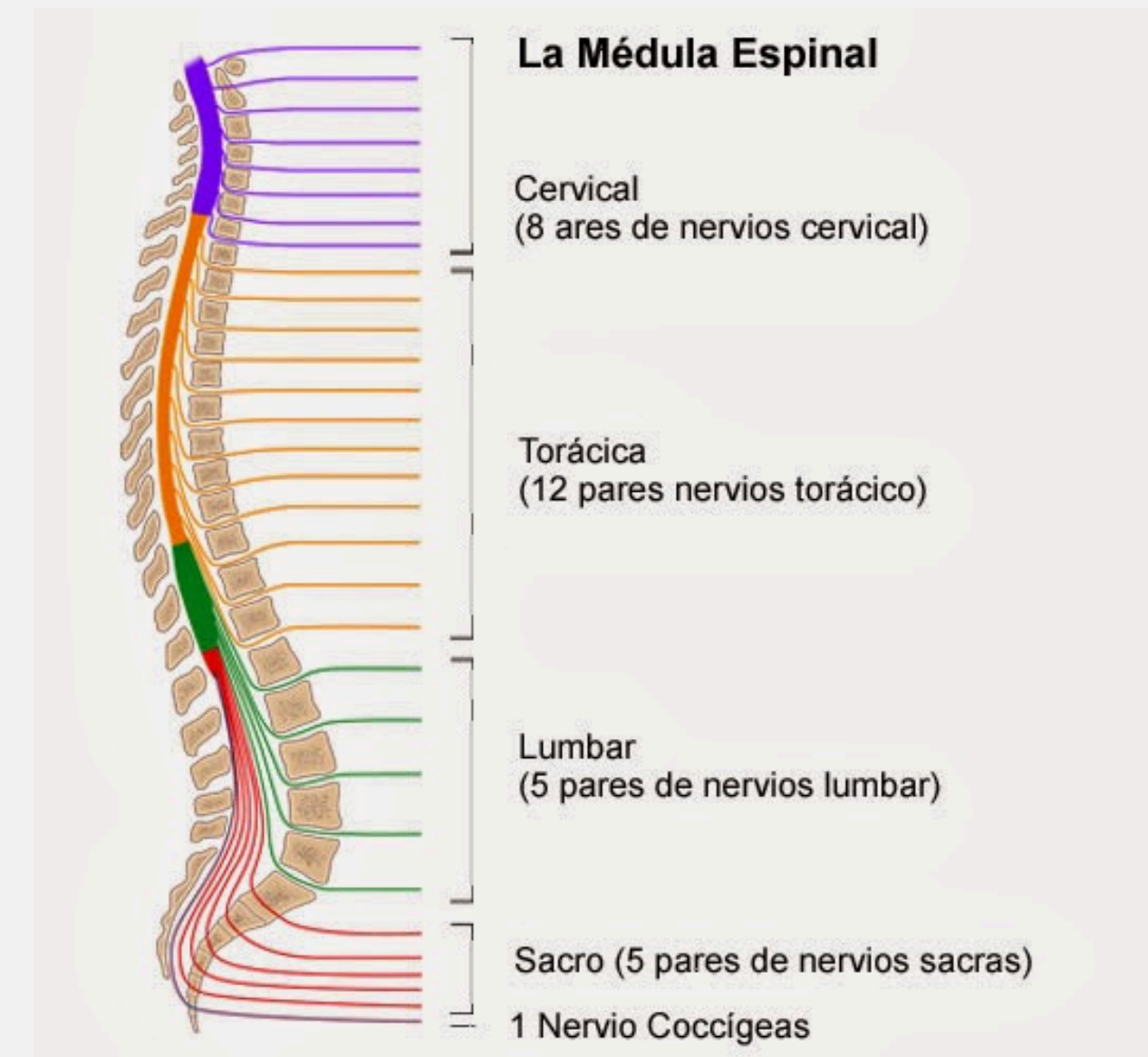
Sus hijos lo apoyan económicamente, además su tía es clave para acompañarlo y asistirlo.

Diagnósticos e historial médico:

Lesión medular cervical incompleta con potencial funcional para rehabilitación.

Diagnóstico principal

Traumatismo de médula espinal a nivel C4 clasificado como AIS D, ocasionado por ataque con arma blanca.



Estado psicosocial / Desempeño funcional y comunicación

- Come con la mano izquierda por dificultad en mano derecha
- Actualmente no trabaja
- No puede realizar tareas del hogar
- Lúcido, orientado y comunica respuestas de forma comprensible

Palomino señala que su hija firmó la carta de compromiso y su mayor red de apoyo actual es su tía y sus hijos.

Se tiene contemplada una evaluación por traumatología para definir la posibilidad de progresar hacia bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas adicionales, según evolución.

Estado neuromuscular y musculoesquelético

Informe clínico inicial:

Movilidad:

Nivel motor C5 derecho y C6 izquierdo, con asimetría y mayor compromiso del lado derecho

Fuerza muscular

Movilidad activa disminuida en las cuatro extremidades.

Tono muscular

Incrementado en las cuatro extremidades (espasticidad), Ashworth 2-3

Reflejos

Hiperreflexia, clonus presente

Marcha y traslados

El paciente refiere realizar sus desplazamientos principalmente con andador

Afección a la piel

Informe clínico inicial:

Presenta piel descamativa y seca a nivel distal de los miembros inferiores, con coloración oscura en los dedos de los pies y onicodistrofia bilateral (dermatodistrofia), sin signos clínicos de trombosis venosa.



Entrevista

Durante la entrevista reciente, el paciente refiere no presentar dolor articular actualmente, sino que presenta adormecimiento del lado derecho, desde el hombro hacia el antebrazo y desde la rodilla hasta la punta de los pies.

Movilidad personal y entorno

Entorno real

- El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR),
- En su vivienda no suele moverse mucho

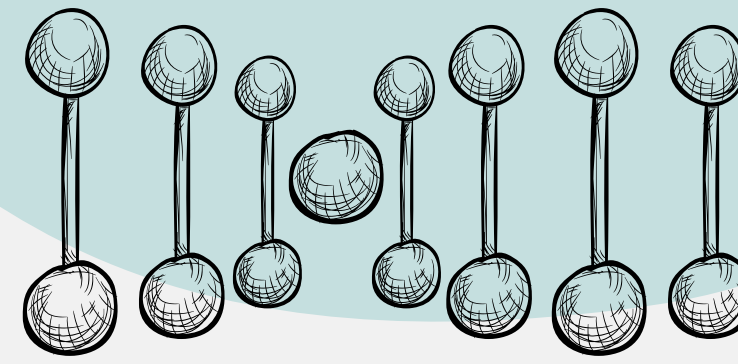
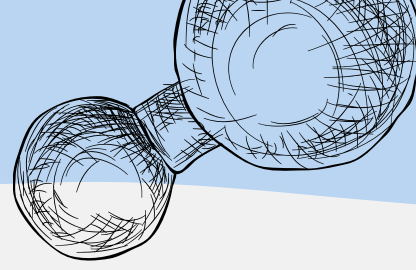
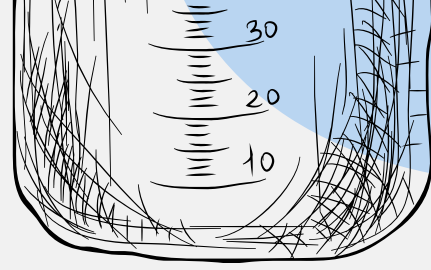
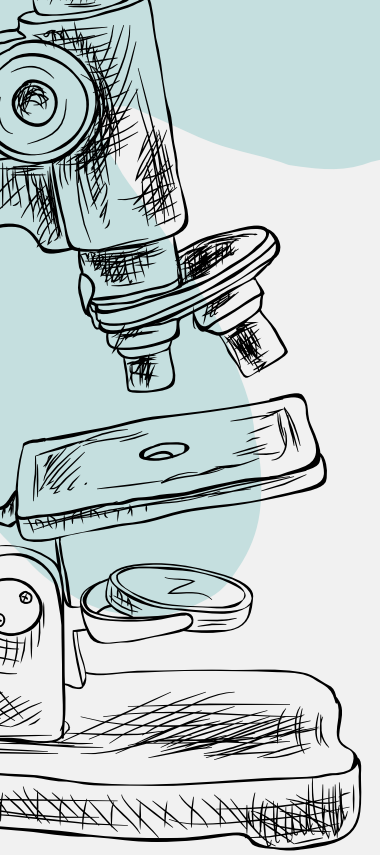
Hallazgos de movilidad

- Realiza bipedestación asistida para efectuar transferencias hacia la silla de ruedas.
- Desplazamiento con andador
- Transporte en auto con apoyo de su tía
 - no tiene problemas para moverse dentro de su vivienda con su andador

Equipo actual

El paciente cuenta con un andador propio, para desplazamientos dentro y fuera de su domicilio.

Se evaluará, según evolución y previa valoración por traumatología, la indicación de ayudas biomecánicas adicionales orientadas a la bipedestación y la marcha.



**¡Muchas
gracias!**

